



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
TIM GERIATRI
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tujuan	1
BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN	2
2.1 SDM.....	2
2.1.1 Ketenagaan	3
2.1.2 Orientasi.....	3
2.1.3 Pendidikan dan Pelatihan	3
2.1.4 Evaluasi Kinerja Staf	3
2.2 Pengembangan Pelayanan.....	4
2.3 Kegiatan Pelayanan Unit/ Instalasi	4
2.4 Fasilitas Kesehatan dan K3	5
2.4.1 Fasilitas Kesehatan.....	5
2.4.2 Gedung dan Bangunan.....	5
2.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	5
2.5 Mutu Prioritas Internal Unit	6
2.6 PPI	6
2.7 PKRS	6
BAB III CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	4
BAB IV SASARAN	4
BAB V JADWAL MELAKSANAKAN KEGIATAN	8
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	12
BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN	12
BAB VIII PENUTUP	13

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, Pemerintah menetapkan beberapa program nasional yang menjadi prioritas. Program prioritas tersebut pelayanan geriatri. Implementasi program ini di rumah sakit dapat berjalan baik apabila mendapat dukungan penuh dari pimpinan/direktur rumah sakit berupa penetapan regulasi, pembentukan organisasi pengelola, penyediaan fasilitas, sarana dan dukungan finansial untuk mendukung pelaksanaan program.

Maka Rumah Sakit Prima Husada menyusun program kerja Geriatri rumah sakit prima Husada.

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap terjadinya penurunan angka kelahiran, angka kesakitan, dan angka kematian serta peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Populasi usia lanjut di Indonesia yang pada tahun 1960 baru berjumlah 4,5 juta, meningkat menjadi 8,0 juta pada tahun 1980 dan diprediksi akan bertambah menjadi 14,9 juta pada tahun 2000.

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak di dunia, yang mencapai 18,1 juta jiwa atau 7,6 persen dari total penduduk. Badan Pusat Statistik (2013) memproyeksikan, jumlah penduduk lanjut usia (60+) diperkirakan akan meningkat menjadi 27,1 juta jiwa pada tahun 2020, menjadi 33,7 juta jiwa pada tahun 2025 dan 48,2 juta jiwa tahun 2035.

Peningkatan jumlah penduduk berusia lanjut tersebut di atas akan menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam bidang kesejahteraan pada umumnya dan kesehatan pada khususnya. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar pada lanjut usia adalah masalah kesehatan akibat proses degeneratif, hal ini ditunjukkan oleh data pola penyakit pada lanjut usia. Berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2013, penyakit terbanyak pada lanjut usia terutama adalah penyakit tidak menular antara lain hipertensi, osteo arthritis, masalah gigi-mulut, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan Diabetes Mellitus (DM).

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan lanjut usia ini cukup besar. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi sehingga untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengembangan kelompok lanjut usia.

Pemecahan masalah dilaksanakan dengan melaksanakan upaya-upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada semua tingkat pelayanan kesehatan di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan kesehatan geriatri di rumah sakit. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan geriatri di rumah sakit yang berkualitas, merata dan terjangkau maka pelayanan geriatri harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan yang bersifat interdisiplin oleh berbagai tenaga profesional yang bekerja dalam tim terpadu geriatri. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan geriatri di rumah sakit dan untuk mengakomodasi berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan geriatri, perlu disusun penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 229/Menkes/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pelayanan Psikogeriatri.

-
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit.
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 002/DPM/I-KEP/DIR/IV/2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada.
 10. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 001/DPM/I-KEP/DIR/II/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.
 11. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang Nomor 1118/I-KEP/DIR/VII/2022 tentang Penetapan Tim Geriatri.

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitas fisik yang sesuai
- b. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia
- c. Melakukan diagnosis dini secara tepat
- d. Melakukan pengobatan yang tepat
- e. Memberikan bantuan moril dan perhatian sampai akhir hayat



BAB II

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

2.1 Sumber Daya Manusia

2.1.1 Ketenagaan

Sesuai dengan PMK Nomor 79 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, kebutuhan tenaga di tim geriatri tingkat pelayanan lengkap adalah sebagai berikut :

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI	JUMLAH KEBUTUHAN
Ketua	Dokter Spesialis	1 orang
Sekretaris	DIII/S1 Keperawatan	1 orang
Anggota	DIII/S1 Keperawatan, S1 Farmasi, S1 Gizi, DIII Fisioterapis	11 orang

2.1.2 Orientasi

Orientasi dalam program kerja Tim Geriatri meliputi :

1. Orientasi Umum yaitu orientasi mengenai profile company, tentang perumahsakitan, Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Keselamatan Pasien.
2. Orientasi Khusus yaitu orientasi yang dilakukan oleh Ketua Tim Geriatri mengenai uraian tugas Tim Geriatri, tanggung jawab dan wewenang.

2.1.3 Pendidikan dan Pelatihan

Rumah sakit mempunyai program pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk pimpinan rumah sakit serta semua staff yang terlibat. Staff yang berada di unit kerja maupun di Tim Geriatri memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai geriatri.

2.1.4 Evaluasi Kinerja Staf

1. Evaluasi kinerja staff dilakukan setiap 6 bulan sekali.
2. Evaluasi kinerja staff meliputi perilaku dan pengembangan profesi kinerja klinis.

2.2 Pengembangan Pelayanan

Tim Geriatri dapat melakukan upaya pengembangan pelayanan geriatri untuk mengantisipasi kompleksitas kasus penyakit dan permasalahan kesehatan pasien geriatri serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan geriatri yang aman, terjangkau dan bermutu. Upaya pengembangan pelayanan geriatri dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang geriatri. Ruang lingkup perkembangan pelayanan geriatri meliputi :

1. Perkembangan sumber daya manusia

N O	RENCANA KEGIATAN	TUJUAN	CARA MELAKUKAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	Diklat Geriatri	Meningkatkan kompetensi anggota Tim Geriatri	Inhouse Training Mendata anggota Tim Geriatri yang belum ikut Diklat Membuat TOR Rapat, Persiapan,	Anggota Tim Geriatri	100% anggota Tim Geriatri 13 orang	Sertifikat Peserta

			Pelaksanaan , Laporan			
--	--	--	--------------------------	--	--	--

2. Perkembangan jenis pelayanan
 Tingkat jenis pelayanan dapat berubah atau ditingkatkan dari tingkat lengkap menjadi tingkat sempurna dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

3. Perkembangan sarana, prasarana dan peralatan

N O	RENCANA KEGIATAN	TUJUAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	Ruang Bangsal Geriatri Akut	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Geriatri	Diusulkan	Ruang Rawat Inap	Tahun 2022	Tersedianya Ruang Bangsal Geriatri Akut sesuai pelayanan geriatri tingkat lengkap

2.3 Kegiatan Pelayanan Unit/ Instalasi

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Menyediakan pelayanan geriatri di 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap	• Melakukan Monitoring (oleh Tim Geriatri) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
2	Melaksanakan Program pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Community Geriatric Service) : 1. Pelayanan Kesehatan Kelompok Lanjut Usia (Posyandu Lansia). 2. Program Perawatan Warga Lanjut Usia di Rumah (Home Care).	• Melakukan Monitoring (oleh Tim Geriatri) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
3	Penyelenggaraan Senam Lansia (Geriatri)	• Melakukan Monitoring (oleh Tim Geriatri) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
4	Penyelenggaraan kegiatan rohani (pengajian)	• Melakukan Monitoring (oleh Tim Geriatri) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi
5	Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan geriatri di Rumah Sakit	• Melakukan Monitoring (oleh Tim Geriatri) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut

		•Melakukan Evaluasi
6	Rapat kordinasi Tim Geriatri Rumah Sakit	Membahas kegiatan Geriatri • Melakukan Monitoring (oleh Tim Geriatri) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan Evaluasi

2.4 Mutu Prioritas Internal Unit

Tim Geriatri wajib melakukan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan geriatri secara berkesinambungan untuk mewujudkan keberhasilan pelayanan geriatri bagi pasien geriatri. Pemantauan dan evaluasi mutu tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan pencatatan dan pelaporan yang memuat :

1. Lama Perawatan
Lama rawat pasien geriatri di ruang rawat inap akut tergantung dari kemampuan TTG serta dukungan sarana dan prasarana. Makin terampil dan lengkap, lama rawat akan semakin singkat. Rata-rata lama rawat pasien geriatri yang masuk karena mengalami *geriatric giants* dan di rawat inap dengan menerapkan pengkajian paripurna pasien geriatri adalah 12 hari.
2. Status Fungsional
Status fungsional pasein diukur sejak pasien masuk rumah sakit sampai saat pemulangan. Diukur rata-rata kenaikan skor status fungsional pasien geriatri dengan karakteristik seperti diatas adalah 4/20 jika menggunakan instrument ADL Barthel.
3. Kualitas Hidup
Penilaian kualitas hidup harus menggunakan instrument yang mampu menilai kualitas hidup terkait kesehatan (*health related quality of life* = HRQoL). Salah satu instrument yang sering digunakan adalah EQ5D (*Euro-Quality of Life Five Dimension*) yang mengukur lima dimensi atau aspek yang memengaruhi kesehatan. Standar nilai EQ5D $\geq 0,71$ dengan EQ5D-VAS minimal 79%.
4. Rawat Inap Ulang (Rehospitalisasi)
Rehospitalisasi adalah perawatan kembali setelah pulang ke rumah dari rumah sakit. Perawatan yang terjadi kembali dalam 30 hari pertama pascarawat menggambarkan adanya permasalahan kesehatan yang sesungguhnya belum optimal ditatalaksana di rumah sakit. Persentase maksimal rehospitalisasi pasien geriatri pascarawat inap akut adalah 15%. Rehospitalisasi ini dapat dipengaruhi oleh kesiapan tim terpadu geriatri serta dukungan yang ada di rumah sakit. Rehospitalisasi juga tidak terlepas dari pengaruh kemampuan puskesmas dan *community based geriatric service*.
5. Kepuasan Pasien
Kepuasan pasien diukur saat pasien pulang dengan instrument yang secara sahiih dapat mengukur kepuasan pasien. Salah satu instrument yang sering digunakan adalah *Patients's Satisfaction Questionair* (PSQ) yang telah diuji kesahihan (Spearman correlation coefficient : 0,383 – 0,607 ; $p < 0,01$) dan keandalannya (Cronbach's alpha : 0,684). Instrument ini memiliki nilai standar minimal 190.

2.5 PKRS

Promosi kesehatan yang di lakukan tim geriatri dilaksanakan pada saat senam geriatic dan menjadi kesatuan rangkaian acara senam geriatri di minggu ke 2 dan ke 4 hari jumat. Rincian kegiatannya sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JAM	ACARA	TEMPAT
1.	12/08/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan Gula Darah - Senam Lansia - Penyuluhan Hypertensi - Pembagian Makan dan Minum	Depan Masjid atau Poli Blok 3
2.	26/08/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan Asam Urat - Senam Lansia - Penyuluhan OA - Pembagian Makan dan Minum	Depan Masjid atau Poli Blok 3
3.	09/09/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan Kolesterol - Senam Lansia - Penyuluhan TBC - Pembagian Makan dan Minum	Depan Masjid atau Poli Blok 3
4.	23/09/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan Katarak - Senam Lansia - Penyuluhan Katarak - Pembagian Makan dan Minum	Hall Sakura Lantai 5
5.	14/10/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan IMT - Senam Lansia - Penyuluhan Gizi Seimbang - Pembagian Makan dan Minum	Depan Masjid atau Poli Blok 3
6.	28/10/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Senam Lansia - Pelatihan Perawatan Jenazah - Pembagian Makan dan Minum	Hall Sakura Lantai 5
7.	11/11/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan Tes Pendengaran - Senam Lansia - Penyuluhan Kanker Payudara - Pembagian Makan dan Minum	Hall Sakura Lantai 5
8.	25/11/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan EKG - Senam Lansia - Penyuluhan Gagal Jantung - Pembagian Makan dan Minum	Hall Sakura Lantai 5
9.	09/12/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Senam Lansia	Depan Masjid atau Poli Blok 3

			- Penyuluhan Dyspepsia - Pembagian Vitamin - Pembagian Makan dan Minum	
10.	23/12/2024	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan Hb - Senam Lansia - Penyuluhan Gagal Ginjal - Pembagian Makan dan Minum	Depan Masjid atau Poli Blok 3
11.	13/01/2025	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan Spirometri - Senam Lansia - Penyuluhan Pneumonia - Pembagian Makan dan Minum	Hall Sakura Lantai 5
12.	27/01/2025	07.00 – 08.00	- TTV - Pemeriksaan Papsmear - Senam Lansia - Penyuluhan Infeksi Saluran Kencing - Pembagian Makan dan Minum	Hall Sakura Lantai 5

BAB III

CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Rapat Tim Geriatri
2. Sosialisasi
3. Pelaksanaan
4. Analisis
5. Evaluasi dan Pelaporan



NO	RINCIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET PENCAPAIAN	ALAT PENGUKUR
1.	Menyediakan pelayanan geriatri di : 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap	Setiap hari	1. Semua pasien geriatri rawat jalan 2. Semua pasien geriatri di ruangan rawat inap	100%	RM Pasien
2.	Melaksanakan Program pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Community Geriatric Service) :	Setiap 2 minggu sekali di hari minggu, Pada minggu ke 2 dan ke 4	warga lanjut usia	100%	• Observasi • Evaluasi • Analisis • Pencatatan dan pelaporan

	1. Pelayanan Kesehatan Kelompok Lanjut Usia (Posyandu Lansia). 2. Program Perawatan Warga Lanjut Usia di Rumah (Home Care).				
3.	Penyelenggaraan Senam Lansia (Geriatric)	Setiap 2 minggu sekali Di hari Jum'at minggu ke 2 dan ke 4 Jam 07.00-08.00	Peserta dari pasien geriatri rumah sakit Prima Husada	100%	• Observasi • Evaluasi • Analisis • Pencatatan dan pelaporan
4.	Penyelenggaraan Kegiatan Rohani (Pengajian)	Setiap 2 minggu sekali Di hari Rabu minggu ke 2 dan ke 4 Jam 07.00	Peserta dari pasien geriatri rumah sakit Prima Husada	100%	• Observasi • Evaluasi • Analisis • Pencatatan dan pelaporan
5.	Mendoakan pasien	Setiap 1 minggu 3x setiap hari senin, kamis dan jum'at	Peserta dari pasien geriatri rumah sakit Prima Husada	100%	• Observasi • Evaluasi • Analisis • Pencatatan dan pelaporan
6.	Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan geriatri di Rumah Sakit	Setiap hari	Semua pasien geriatri di rumah sakit prima husada	100%	• Observasi • Evaluasi • Analisis • Pencatatan dan pelaporan
7.	Rapat kordinasi Tim Geriatri Rumah Sakit	Setiap satu bulan sekali Pada hari Jumat Minggu ke 4	Semua Tim Geriatri	100 %	• Evaluasi • Analisis • Pencatatan dan pelaporan

BAB V
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	SASARAN	PELAKSANAAN												TEMPAT	PELAKSANA	SUMBER DANA	METODE	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Menyediakan pelayanan geriatri di 1. Rawat Jalan 2. Rawat Inap	1. Semua pasien geriatri di rawat jalan 2. Semua pasien geriatri di ruangan rawat inap													Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap	Managemen RS Tim Geriatri Unit terkait	RS Prima Husada		
2	Melaksanakan Program pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Community Geriatric Service) : 1. Pelayanan Kesehatan Kelompok Lanjut Usia (Posyandu Lansia). 2. Program Perawatan Warga Lanjut Usia di Rumah (Home Care).	Warga Lanjut Usia													RS Prima Husada	Tim Geriatri	RS Prima Husada		
3	Penyelenggaraan Senam Lansia (Geriatri)	Peserta dari pasien geriatri													RS Prima Husada	Tim Geriatri	RS Prima Husada		

		Rumah Sakit Prima Husada																	
4	Penyelenggaraan Kegiatan Rohani (Pengajian)	Peserta dari pasien geriatri Rumah Sakit Prima Husada													RS Prima Husada	Tim Geriatri	RS Prima Husada		
5	Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan geriatri di Rumah Sakit	Semua pasien geriatri di Rumah Sakit Prima Husada													RS Prima Husada	Tim Geriatri	RS Prima Husada		
6	Rapat kordinasi Tim Geriatri Rumah Sakit	Semua Tim Geriatri													Hall PT. DPM Lantai 2D	Tim Geriatri	RS Prima Husada		

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan guna mewujudkan keberhasilan program pelayanan kesehatan bagi pasien geriatri. Pemantauan dan evaluasi harus ditindaklanjuti untuk menemukan faktor-faktor potensial berpengaruh agar dapat diupayakan penyelesaian yang efektif. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam bentuk kegiatan pencatatan dan pelaporan.

1. Monitoring

NO.	RENCANA KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PETUGAS
1.	Pembuatan laporan triwulan	Pertanggung jawaban kepada Direktur	Laporan Triwulan	Ketua dibantu sekretaris
2.	Monitoring kegiatan Tim Geriatri (senam lansia, kegiatan rohani, posyandu lansia dan home care)	Memantau proses kegiatan yang sedang berlangsung	Anggota Tim Geriatri dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya	Tim Geriatri
3.	Monitoring pelayanan geriatri (rawat jalan dan rawat inap)	Memantau proses pelayanan di unit	Anggota Tim Geriatri dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya	Tim Geriatri

2. Evaluasi

NO.	RENCANA KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PETUGAS
1.	Rapat bulanan sebagai evaluasi kegiatan	Evaluasi program bulanan Membahas masalah yang ada Mencari solusi	Program geriatri dilaksanakan Laporan bulanan tepat waktu	Ketua dibantu sekretaris Anggota Tim Geriatri
2.	Rapat koordinasi Tim Geriatri	Evaluasi terkait pelayanan dan program geriatri	Pelayanan dan program geriatri dilaksanakan Laporan bulanan tepat waktu	Ketua dibantu sekretaris Anggota Tim Geriatri

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan kegiatan di dalam program dilakukan dengan cara tertulis. Laporan program dibuat dengan memasukkan unsur-unsur yang meliputi pencatatan harian, pemeliharaan alat, pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia, dan kalibrasi alat terdapat dalam rincian kegiatan pada program kerja. Laporan di buat setiap satu bulan sekali dengan ditandatangani ketua dan dilaporkan kepada Direktur.



BAB VIII PENUTUP

Pada prinsipnya, program kerja Tim Geriatri telah mengacu dalam peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan. Serta selama pelaksanaan kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi. Dengan diterbitkan dan dibuatnya program kerja ini, diharapkan semua petugas dan anggota Tim yang terkait dalam pelayanan geriatri dapat melaksanakan dengan baik.

Ketua Tim Geriatri



dr. Heriyatmo, Sp. PD

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 31 Juli 2024

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah